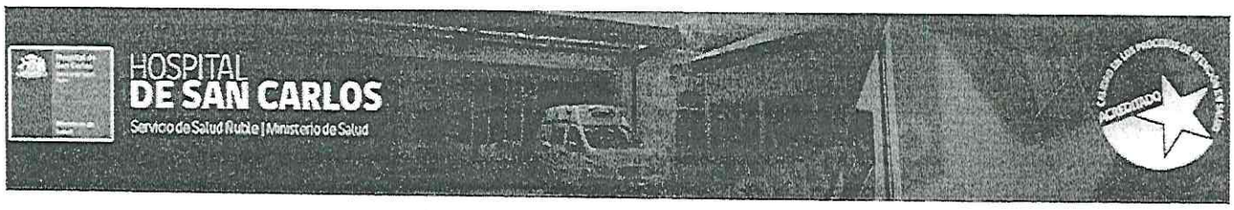

Epicrisis

viernes, 29 de diciembre de 2023; 10:55 a. m.

DATOS GENERALES DEL PACIENTE:

Nombre	
Edad	***DATOS DEL PACIENTE:*** ***Nombre : NELSON SEBASTIAN SOTO CANDIA RUN : 6.072.129-7*** ***F.Nac : 25-02-1949 Edad : 74 AÑOS, 10 MESESs*** ***Género : Masculino Previsión : FONASA D*** ***Dirección : G. VNEGAS 677 Comuna : SAN CARLOS Teléfono : 997224628*** ***Motivo Consulta : MORBILIDAD COMUN***
Diagnóstico de EGRESO	Infección de vías urinarias, sitio no especificado. Hipertensión arterial (HTA). Hipotiroidismo. tromboembolismo pulmonar (TEP) debido a antecedente de dímero D alto y taquicardia DESCARTADO

PARÁMETROS ACTUALES:

PA	135	85	Mmgh	FC	107	Lpm	FR	11	Rpm
Tax	36.5	°C	HGT	117	mg/dl	Sat O2	95	%	

EVOLUCIÓN

74 años y 10 meses
Género: Masculino
Antecedentes Médicos:
Hipertensión arterial (HTA)
Posible infarto agudo de miocardio (IAM) previo (se necesita confirmación)
Antecedentes Quirúrgicos: No
Alergias: No
El paciente experimentó un episodio de lipotimia en la vía pública, que duró dos minutos y se recuperó completamente posteriormente. Además, informa que ha tenido orinas turbias y con mal olor, así como síntomas respiratorios. Tuvo una infección del tracto urinario (ITU) en noviembre, que fue tratada con tratamiento oral. Refiere síntomas actuales de lipotimia, poliuria y nicturia.
Se realizaron exámenes de laboratorio que mostraron un PCR elevado de 301, leucocitos de 14600 y un dímero D de 1498.7. La orina también mostró anomalías. Debido a estos hallazgos, se decide hospitalizar al paciente para su evaluación y posterior postulación para HODOM (evaluación de tromboembolismo pulmonar descartada).

Examen Físico:
Vigil; consciente; orientado en tiempo y espacio
Mucosas rosadas, bien hidratadas, llenado capilar < 2 segundos
Auscultación cardíaca: ritmo regular sin soplos
Auscultación pulmonar: murmullo pulmonar positivo con crepitantes finos en bases

PLAN

HODOM

Indicaciones

1. HODOM
2. Reposo absoluto.
3. Régimen liviano en horario de sueño (HS).
4. Hidratación 60 cc hora.
5. Ceftriaxona 2 gramos por vía intravenosa (IV).
6. Omeprazol 20 mg por día (D).
7. Atenolol 50 mg comprimidos una vez al día.
8. Aspirina 100 mg comprimidos una vez al día.
9. Hidroclorotiazida 50 mg comprimidos una vez al día.
10. Levotiroxina 100 mcg comprimidos una vez al día.
11. Control serio-vital (CSV) cada 8 horas.